

1 – Como realizar a avaliação antropométrica e ingestão dietética?

A **avaliação antropométrica** é realizada combinando medidas isoladas e índices corporais adequados para a idade. Utilizam-se medidas como **peso** (aferido com a criança em pé, descalça e com o mínimo de roupas), **estatura e circunferências** (como a do braço e da cintura). Além disso, **dobras cutâneas** (como a tricipital e subescapular) podem ser aferidas para estimar a **reserva adiposa e a composição corporal**. A **ingestão dietética** é avaliada por métodos **quantitativos e qualitativos** para obter o consumo habitual ou atual de energia e nutrientes. Para a infância e adolescência, aplicam-se **inquéritos prospectivos** (como o Registro Alimentar) ou **retrospectivos** (como o Recordatório de 24 horas e o Questionário de Frequência Alimentar - QFA). O **Recordatório de 24h** tem a vantagem de ser rápido e não alterar o comportamento alimentar, enquanto o QFA é excelente para identificar os padrões de consumo.

2 – Quais os índices indicados para adolescentes?

Na adolescência (10 a 19 anos), a classificação do estado nutricional requer o uso de curvas de **referência por sexo e idade**. Os índices exclusivamente indicados para os adolescentes são o **IMC por idade** (Índice de Massa Corporal para idade) e a **Estatura/Altura por idade**. Além destes índices, a avaliação é complementada pelo acompanhamento de **medidas de circunferências (braço, cintura, panturrilha e pescoço) e dobras cutâneas (tríceps e subescapular)** para observar a distribuição da gordura e a reserva muscular.

VALORES CRÍTICOS		ÍNDICES ANTROPOMÉTRICOS						
		CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS INCOMPLETOS				CRIANÇAS DE 5 A 10 ANOS INCOMPLETOS		
		Peso para idade	Peso para estatura	IMC para idade	Estatura para idade	Peso para idade	IMC para idade	Estatura para idade
< Percentil 0,1	< Escore-z -3	Muito baixo peso para a idade	Magreza acentuada	Magreza acentuada	Muito baixa estatura para a idade	Muito baixo peso para a idade	Magreza acentuada	Muito baixa estatura para a idade
≥ Percentil 0,1 e < Percentil 3	≥ Escore-z -3 e < Escore-z -2	Baixo peso para a idade	Magreza	Magreza	Baixa estatura para a idade	Baixo peso para a idade	Magreza	Baixa estatura para a idade
≥ Percentil 3 e < Percentil 15	≥ Escore-z -2 e < Escore-z -1	Peso adequado para a idade	Eutrofia	Eutrofia	Estatura adequada para a idade ¹	Peso adequado para a idade	Eutrofia	Estatura adequada para a idade ²
≥ Percentil 15 e ≤ Percentil 85	≥ Escore-z -1 e ≤ Escore-z +1		Risco de sobrepeso	Risco de sobrepeso			Sobrepeso	
> Percentil 85 e ≤ Percentil 97	> Escore-z +1 e ≤ Escore-z +2	Peso elevado para a idade ¹	Sobrepeso	Sobrepeso		Peso elevado para a idade ¹	Obesidade	
> Percentil 97 e ≤ Percentil 99,9	> Escore-z +2 e ≤ Escore-z +3		Obesidade	Obesidade			Obesidade grave	
> Percentil 99,9	> Escore-z +3							

3 – Como Utilizar as recomendações nutricionais para diagnóstico da ingestão dietética em adolescentes? Como avaliar qualitativamente a ingestão de micronutrientes do adolescente?

Para a avaliação (diagnóstico) da dieta de um indivíduo, deve-se utilizar a **EAR (Necessidade Média Estimada)**, que permite calcular a **probabilidade** de a ingestão habitual estar inadequada.

- < EAR: alta probabilidade de inadequação;
- EAR-RDA, baixa probabilidade de adequação
- > RDA: baixa probabilidade de inadequação
- > UL: risco de toxicidade e excesso.

A RDA **não** deve ser usada para avaliar dietas individuais, servindo apenas como meta para planejamento. A avaliação qualitativa da ingestão de micronutrientes deve ser feita identificando **frequências de adequação ou inadequação do consumo e fatores de risco associados** (como a baixa ingestão de leites interferindo no cálcio ou a baixa ingestão de fontes de ferro e vitamina A). É possível utilizar inquéritos como o **QFA** e avaliar as porções diárias ingeridas, identificando o excesso de alimentos ultraprocessados ou o déficit nos grupos de frutas, legumes e verduras.

4 – O que deve ser avaliado para realizar o diagnóstico nutricional do adolescente?

- **Antropometria:** peso, altura, IMC, circunferências) classificando o estado nutricional nas curvas de referência.
- **Alimentação:** qualidade, quantidade, ingestão de macro e micronutrientes, ambiente, consumo de bebidas açucaradas e fast food, e horários irregulares
- **Exames laboratoriais:** perfil lipídico, glicemia, HOMA-IR, hemograma, etc.

Adicionalmente, devem ser avaliados **critérios clínicos e comportamentais:**

- **antecedentes pessoais e familiares** (comorbidades), **sintomas** (ex: acantose nigricans), **estadiamento puberal**, percepção da própria **imagem corporal**, **atividade física**, **tempo de tela**, padrão de **sono**, uso de **medicamentos**, além de **tabagismo** e consumo de **álcool**.

5 - Como abordar o tratamento dietético na adolescência, hábitos e erros alimentares?

Os **erros alimentares mais comuns** na adolescência incluem o padrão desordenado com **omissão de refeições** (especialmente o café da manhã), substituição de refeições principais por **lanches**, e **alta ingestão de refrigerantes, doces, gorduras e ultraprocessados**, com **baixo aporte de vitaminas e fibras**. A abordagem do tratamento dietético deve evitar o **autoritarismo** e focar no **ensino da proporção, variedade e moderação**. O nutricionista precisa ser **flexível e orientar sobre a quebra de horários, lanches para a escola, festas e substituição de refeições**. As intervenções incluem o incentivo à **regularidade das refeições** (ex: 3 principais e 2 lanches), adequação do tamanho das porções, educação para a leitura de rótulos e estímulo a refeições feitas em família à mesa (sem equipamentos com tela), além de trabalhar a **percepção de fome, saciedade e o manejo das emoções**.

6 - Como deve ser avaliada e recomendada a ingestão hídrica correta?

A baixa ingestão hídrica deve ser avaliada clinicamente, pois está diretamente associada a queixas de **fezes ressecadas e constipação**. A recomendação de ingestão total de água (que inclui a água contida em alimentos e bebidas, correspondendo a cerca de 70-80% de líquidos) na adolescência deve seguir as faixas etárias:

- **meninos de 9–13 anos (2,4 L/dia) e meninas de 9–13 anos (2,1 L/dia);**
- **e para meninos de 14–18 anos (3,3 L/dia) e meninas de 14–18 anos (2,3 L/dia).**
- Em idades menores, a necessidade pode ser calculada pela **regra de Holiday-Segar** (ex: 100 mL/kg até os primeiros 10 kg de peso).

7 – Quais as características fisiológicas do adolescente?

As características fisiológicas da adolescência são marcadas pela **puberdade**, envolvendo transformações biológicas determinadas por estímulos hormonais do eixo **hipotálamo-hipófise-gônadas**. Esse período (geralmente com a liberação de hormônios entre os 8 e 12 anos) é o momento em que a criança progride para um estado sexualmente maduro, desenvolvendo as **características sexuais secundárias**, que são avaliadas nos meninos e meninas através dos diferentes **Estágios de Tanner** (desenvolvimento de mamas, genitália e pelos pubianos). Fisiologicamente, também ocorre a **aceleração do crescimento longitudinal (o estirão de crescimento)** e uma modificação brutal na composição e massa corporal, onde o adolescente ganha em torno de **50% de seu peso final** durante a fase puberal.

8 - Qual etiopatogenia dos transtornos alimentares abordados, os comportamentos alimentares característicos? Quais são as terapias nutricionais recomendadas?

Em relação ao **Transtorno da Compulsão Alimentar (TCA)**, a etiopatogenia está muitas vezes associada à **obesidade e ao ciclo de atitudes negativas**: o paciente sente **culpa, que leva à vergonha, progredindo para depressão e culminando no excesso de alimentos**. Os **comportamentos alimentares** incluem episódios **hipercalóricos** (+1000 kcal do que obesos sem TCA), ingestão excessiva alternada com ingestão insuficiente, aumento no consumo de **fast-foods, sobremesas e produtos diet/light**, e escolhas por alimentos de **alta palatabilidade e fáceis de ingerir**, resultando em baixo consumo de **proteínas, fibras, vitaminas e minerais**. A **terapia nutricional recomendada** envolve cessar os episódios de compulsão e focar na melhora da estrutura, atitude e consumo alimentar do indivíduo. Utiliza-se também a **TCC automonitorização** e seguimento das recomendações das diretrizes para tratamento do excesso de peso e outras doenças crônicas.

9 - Quais as comorbidades e como deve ser o tratamento nutricional?

As comorbidades mais frequentes ligadas à obesidade infantil e juvenil incluem a **RI, HAS, Dislipidemia, o Fígado Gorduroso** (com danos hepáticos semelhantes à doença alcoólica) e o **DM2**, que na adolescência possui evolução mais rápida e agressiva do que em adultos. O **tratamento nutricional** exige intervenção precoce, visando **reduzir o sedentarismo e estimular a prática regular de atividade física**. Dietoterapeuticamente, recomenda-se orientação para uma **dieta adequada em quantidade e qualidade**; a utilização da dieta

CHILD para tratar fatores de **risco cardiometabólicos**; a indicação de padrões alimentares como a dieta **DASH, Mediterrânea e dietas baseadas em plantas** (para DM2 e resistência à insulina); e o **rigoroso controle do sódio** (limite de 5g de sal ou 2g de sódio por dia).

10 - Conceituar fibrose cística e sua abordagem nutricional.

A abordagem nutricional deve ser bastante agressiva para manter a função pulmonar, promover o ganho de peso e quebrar o ciclo de infecção-desnutrição. A **terapia nutricional** envolve uma **dieta hipercalórica (110 a 200% das RDAs de energia), hiperproteica (20% das calorias) e hiperlipídica (35 a 40% do VET, priorizando triglicerídeos de cadeia média)**. Além disso, a conduta inclui a **suplementação de enzimas pancreáticas**, reposição rigorosa de **sódio** (que pode chegar a 6000 mg em adolescentes, com cuidado no calor) e suplementação de **vitaminas lipossolúveis e minerais como zinco e cálcio**. Quando não é possível atingir as calorias, indica-se Terapia Nutricional via **sondas** ou **gastrostomia** noturna, mantendo **40-50% das necessidades diárias**.

11 - Tare o que é, como é diagnosticado e como deve ser o tratamento

É uma **perturbação do comportamento alimentar** onde há um fracasso persistente em atingir as **necessidades nutricionais e/ou energéticas diárias**. Apresenta-se em três subtipos principais:

- **Apetite limitado:** Falta aparente de interesse na comida, pouco volume ingerido e saciedade precoce.
- **Seletividade:** Esquiva baseada na alta sensibilidade às características sensoriais do alimento (textura, cor, cheiro).
- **Medo de consequências:** Preocupação com consequências aversivas após comer, devido a traumas como fobia de engasgar ou vomitar.

O **diagnóstico segue os critérios do DSM-V** e a recusa **não** pode ser explicada por falta de alimento, práticas culturais, causas orgânicas ou ocorrer exclusivamente na Anorexia ou Bulimia. A **perturbação deve estar associada a pelo menos um destes impactos graves**:

- **Perda de peso significativa** ou atraso no crescimento (em crianças).
- **Deficiência nutricional grave.**
- **Dependência de suplementos nutricionais orais** ou alimentação por **sonda** (enteral).
- Forte interferência (prejuízo) no funcionamento **psicossocial**.

Exige uma **abordagem transdisciplinar** (terapeuta ocupacional, nutricionista, psiquiatra) focada em desarticular o mecanismo que causa a recusa e minimizar prejuízos clínicos. **O planejamento é dividido em 3 etapas**:

- **Estabilidade clínica:** Foco inicial para **recuperar** o estado nutricional, **corrigir deficiências** e avaliar a necessidade de **internação ou suplementação**.
- **Mecanismos mantenedores:** Identificar o que mantém a **recusa** e utilizar terapias como a **CBT-AR (TCC)** para redução de **estresse e psicoeducação**.

- **Autonomia alimentar:** Aplicação de estratégias de enfrentamento e **exposição gradual, visando ampliar o repertório** (variedade) de alimentos aceitos, aumentar o **volume** tolerado e melhorar a **dinâmica** no momento das refeições.

12 - Quais os aspectos da dieta vegetariana na infância. Como deve ser o planejamento dietoterápico?

- **É segura e saudável:** Quando bem planejada, garante crescimento, desenvolvimento e antropometria adequados e semelhantes aos de crianças onívoras, sendo respaldada por diversas sociedades de pediatria.
- **Não causa deficiências inerentes:** Não apresenta maior risco de anemia do que dietas onívoras se bem estruturada. A desnutrição em casos isolados ocorre por erros graves na estruturação alimentar (como dietas restritivas extremas ou falta de calorias/proteínas), e não pela exclusão da carne em si.
- **Motivações:** Pode ser motivada por escolha da família, ativismo ambiental ou recusa espontânea da criança à carne.

Como deve ser o planejamento dietoterápico e pontos de atenção

- **Proteínas:** O conceito de "proteína incompleta" é obsoleto. Deve-se garantir a combinação de **cereais** (arroz, milho, aveia) e **leguminosas** (feijões, lentilha, grão-de-bico, ervilha, soja) ao longo do dia para fornecer todos os **aminoácidos essenciais**, além de **não focar em ultraprocessados**.
- **Vitamina B12: A suplementação é obrigatória** para todas as crianças e adolescentes vegetarianos e veganos (inclusive ovolactovegetarianos). A dose profilática de manutenção varia com a idade (ex: **5 mcg/dia de 6 meses a 3 anos; 50 mcg/dia para maiores de 11 anos**).
- **Ferro (Estratégias de absorção):** Como o **ferro vegetal** (não-heme) tem menor **biodisponibilidade**, é fundamental: fazer o **demolho de 12 horas** das **leguminosas** (para reduzir fitatos), consumir fontes de **vitamina C** (ex: laranja, limão) nas refeições principais, e **evitar** consumir **cálcio** (leites/derivados) ou chás e **café logo após o almoço/jantar**.
- **Cálcio:** Atingir a **recomendação** (que aumenta para 1300 mg na adolescência) utilizando **laticínios** (para ovolactovegetarianos) ou **"leites" vegetais fortificados**, além de **vegetais verde-escuros** (couve, brócolis) e **sementes** (gergelim, chia).
- **Outros nutrientes:** A dieta deve incluir fontes de **ômega-3** (óleo e semente de linhaça triturada, chia). É preciso monitorar os níveis de **Vitamina D** para suplementar se necessário e garantir que o **consumo de sal iodado seja suficiente para o iodo**. Por fim, **limitar fortemente alimentos ultraprocessados**.